Prise en charge des pneumonies d'inhalation

Recommandation
SPILF en partenariat avec la SFGG
GINGER

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 08/01/2025

Définitions

- **Pneumonie d'inhalation** (PI) prolifération et invasion bactérienne du parenchyme pulmonaire secondaire à l'inhalation de sécrétions colonisées par des bactéries pathogènes.

A différencier de :

- **Pneumopathie chimique** : Inhalation du contenu gastrique qui peut être à l'origine d'une réaction inflammatoire précoce sans cause bactérienne. Il n'y pas de période d'incubation contrairement à la pneumonie d'inhalation.

- **Obstruction mécanique :** Inhalation de fluides ou matériel obstruant les voies aériennes ou déclenchant un réflexe de fermeture des voies respiratoires, sans réaction inflammatoire parenchymateuse associée.

Critères diagnostiques de la pneumonie d'inhalation

Diagnostic de PI: (1) + (2)

(1) Diagnostic positif de pneumonie

-Signes cliniques d'infection respiratoire aigüe basse

+

-Infiltrat(s) radiologique(s) nouveau(x).

(2) Diagnostic étiologique présomptif d'inhalation

-Troubles de déglutition ou inhalation

ou

-Atteinte clinico-radiologique déclive en présence de facteur(s) de risque d'inhalation

- **Le tableau respiratoire aigu immédiatement secondaire à une fausse route (pneumopathie chimique) ne répond pas à la définition de PI.**

Epidémiologie des PI

- Les bactéries les plus identifiés : *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. aureus*, des enterobacterales
- Moins fréquemment : *P. aeruginosa*
- Les bactéries anaérobies sont actuellement rarement identifiées possiblement en lien avec une amélioration de l'hygiène bucco dentaire et des modalités de documentation microbiologique

Facteurs de risque

- ✓ Troubles de la vigilance
- ✓ Troubles de la déglutition
- ✓ Facteurs favorisant le reflux gastrique : hernie hiatale, sonde naso-gastrique, constipation, syndrome occlusif et iléus, anticholinergiques, grossesse, obésité, ascite
- ✓ Anomalie des réflexes pharyngés au cours des toux et vomissements

Imagerie

- Il est recommandé de réaliser :
  - En priorité un scanner thoracique sans injection
  - A défaut, une échographie pulmonaire
  - Radiographie thoracique uniquement en cas de difficultés d'accès au scanner et à l'échographie

Biologie

- L’utilisation des marqueurs biologiques (VS, CRP, PCT) n’est pas recommandée pour affirmer ou exclure le diagnostic
- Aucun examen complémentaire bactériologique systématique n’est recommandé
- Un ECBC doit être réalisé avant l’initiation d’une antibiothérapie à activité anti-P. *aeruginosa*.
- Les antigénuries (pneumocoque et légionelle) ne sont pas recommandées.
- Pour rappel, Il est recommandé en période épidémique, de réaliser un test diagnostic à la recherche des virus Influenza A/B, du VRS et du SARS-CoV-2

Antibiothérapie

- Traitement de première intention :
  - **amoxicilline - ac. clavulanique** PO ou IV
- Impossibilité d'utiliser la voie orale et IV :
  - ceftriaxone SC en monothérapie
- Si allergie :
  - Allergie à la pénicilline sans contre-indication à l'utilisation des C3G : ceftriaxone IV ou SC en monothérapie
  - Contre-indication aux bétalactamines : cotrimoxazole PO ou IV

Il est recommandé de ne pas associer le métronidazole

Antibiothérapie, situations particulières

- Après une fausse route constatée :
  - Pas d'antibiothérapie, surveillance clinique.
  - Antibiothérapie uniquement en présence des critères de PI
- En l'absence d'évolution favorable à 72h de l'antibiothérapie initiale :
  - Relais par pipéracilline – tazobactam
- En cas de rechute et de récidive d'une PI ayant eu une évolution favorable
  - Reprendre le schéma antibiotique initial

Antibiothérapie des PI présentant des critères de gravités

Considérer les FDR d'infection pouvant impliquer *P. aeruginosa* et SARM.

- Au moins un FDR de *P. aeruginosa* parmi : antécédant de colonisation ou d'infection respiratoire récente (<1 ans) documenté à *Pseudomonas*, antibiothérapie parentérale récente (<3 mois), BPCO sévère, bronchiectasies, trachéotomie.
  - ➢ Piperacilline-tazobactam en traitement probabiliste

- Patients précédemment connu colonisé à SARM.
  - ➢ Ajout du linezolide en traitement probabiliste

- En l'absence de FDR d'infection à *P. aeruginosa* ou à SARM, le traitement est identique à celui recommandé dans les formes sans critères de gravités.

En cas pneumonie grave dont le mécanisme est incertain :

- ➢ Appliquer les recommandations de la SPILF de 2025 sur la PAC grave.

Antibiothérapie

Molécule	Selon DFG	Posologie	Voie
Amoxicilline 1g - acide clavulanique 125mg	> 30 ml/min	1g d'amoxicilline toutes les 8h	PO ou IV (si gravité)
	[10-30]ml/min	1g en dose de charge puis 0.5g toutes les 8h	
	<10ml/min	1g en dose de charge puis 0.5g toutes les 24h	
Ceftriaxone 1g	Pas d'adaptation	1g/24h	IV ou SC
Sulfaméthoxazole 800mg/Triméthoprime 160mg	>30ml/min	800mg de sulfamethoxazole toutes les 8h	PO ou IV
	[15-30]ml/mn	800mg toutes les 24h	
	<15ml/mn	800mg toutes les 48h	
Pipéracilline 4g - Tazobactam 500mg	>20ml/min	4g de pipéracilline toutes les 6 à 8h	IV
	<20ml/min	4g toutes les 12h	

Voies d'administration

- Voie orale en priorité.
- La ceftriaxone par voie sous-cutanée est une alternative
  - ✓ En cas d'impossibilité d'administration par voie orale.
  - ✓ En cas d'impossibilité d'administration par voie IV
  - ✓ En relais de la voie IV après stabilisation et impossibilité de relais par voie orale.

Durée de l'antibiothérapie

- **5 jours en cas d'évolution clinique favorable.**

L'évolution clinique favorable est évaluée à 72 heures par la présence de tous les critères de stabilité clinique suivants :

- ✓ Une température ≤ 37°8 C
- ✓ TA systolique ≥ 90 mm Hg
- ✓ Fréquence cardiaque ≤ 100/min
- ✓ Fréquence respiratoire ≤ 24/min
- ✓ SpO2 ≥ 90 % ou PaO2 ≥ 60 mm Hg en air ambiant

La persistance de la toux n'est pas un critère de non-amélioration

Mesures de prévention secondaire

- Position ½ assise (>30), mobilisation (mise au fauteuil), verticalisation et rééducation précoce
- Tester la déglutition avant la prise orale, Soins d'hygiène bucco-dentaire
- Epaississement des liquides
- Alimentation par SNG ou GPE non efficace pour prévenir les PI
- La scopolamine n'est pas recommandée en prévention des récidives de PI
- Les médicaments qui doivent être réévalués et si possible arrêtés pour éviter la récidive de PI sont :
  - Les médicaments modifiant la vigilance (psychotropes)
  - Les médicaments interférant avec la déglutition (médicaments anticholinergiques)
  - Les inhibiteurs de la pompe à proton

Mesures de prévention

- Réalisation systématique d'un test de déglutition et une évaluation nutritionnelle

Selon les cas :

- Un avis orthophoniste,
- Un avis médical spécialisé (gériatre, ORL, gastro-entérologue, neurologue),
- Examen complémentaire à discuter : imagerie cérébrale, vidéo-fluoroscopie